



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Instituto Universitario de Tecnología “Elias Calixto Pompa”
El Tigre- Anzoátegui

**Caso clínico aplicado a paciente femenino de 47 años.
Diagnóstico: Mioma Abortivo (mioma submucoso en
proceso de expulsión) Hospitalizada en el servicio de
Ginecología- Obstetricia del hospital Dr. Felipe
Guevara Rojas, El Tigre – Edo
Anzoátegui.**

Tutor:
Lcdo. Albys Figueroa

Integrantes:
Alrifai, Amani 31.985.794
Alrifaie, Duaá. 32.311.890
Duerto, Raquel 32.840..310
Horvarth, Ariadna 32.826.815
Serra, Ashli 33.431.359
Rodriguez, Valentina 30.230.010

El Tigre, 24 de Abril de 2026

ÍNDICE.

Introducción

La salud ginecológica suele estar rodeada de tabúes y desinformación que retrasan la búsqueda de atención médica oportuna. El manejo del Sangrado Uterino Anormal (SUA) no debe entenderse únicamente como un procedimiento hospitalario, sino como una prioridad de educación sanitaria. Cuando una mujer desconoce los límites entre un ciclo irregular y una hemorragia patológica, su vida puede verse comprometida por complicaciones silenciosas pero severas, como la anemia crónica o el shock hipovolémico.

El presente estudio analiza el caso de una paciente de 47 años atendida en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, quien presentó un mioma abortivo. Esta patología es uno de los mayores desafíos en la práctica clínica debido a su complejidad diagnóstica, al presentarse con sangrado abundante, dolor pélvico y la expulsión de tejido por el canal vaginal, suele confundirse erróneamente con un aborto espontáneo. Este contexto no solo genera angustia emocional en la paciente, sino que puede inducir a errores en el abordaje médico inicial si no se cuenta con la preparación adecuada para diferenciar una formación benigna de un evento obstétrico.

Partiendo de esta realidad este trabajo tiene un doble propósito pedagógico. En primer lugar, buscar empoderar a la mujer para que aprenda a reconocer señales de alerta como el sangrado acíclico, la presencia de coágulos de gran tamaño y el cansancio extremo que indican que el cuerpo está perdiendo sangre de forma anormal. En segundo lugar, pretende instruir al personal de enfermería sobre la importancia de la exploración física exhaustiva y la anamnesis detallada. Un diagnóstico de mioma abortivo requiere de un ojo clínico entrenado que no se deje llevar por la primera impresión clínica, garantizando así un tratamiento asertivo y una recuperación libre de riesgos para la paciente.

Reseña del Servicio de Ginecología y Obstetricia

La unidad de Ginecología del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas funciona como un núcleo especializado en el abordaje de patologías complejas que afectan la salud integral de la mujer. Más allá de ser un espacio asistencial, el servicio se define por su capacidad de respuesta ante emergencias hemorrágicas, donde la rapidez en la valoración y la precisión técnica del personal de enfermería son determinantes para la supervivencia de la paciente.

Infraestructura y capacidad instalada

El servicio cuenta con una infraestructura diseñada para garantizar atención, privacidad y seguridad. Dispone de 6 cuartos de hospitalización que suman un total de 41 camas, distribuidas estratégicamente para cubrir la demanda de patologías ginecológicas y obstétricas. Además, el área dispone de una sala de aislamiento dividida en dos cuartos: uno con 2 camas y otro con 1 cama, destinados a pacientes con procesos infecciosos o inmunodeprimidos que requieren precauciones adicionales. Para el manejo de patologías específicas, la unidad cuenta con una sala de hipertensión enfocada al control y seguimiento de trastornos hipertensivos del embarazo y otras patologías cardiovasculares en la mujer y una sala de cura equipada para procedimientos de curación avanzada de heridas, úlceras, cuidados postquirúrgicos y manejo de infecciones ginecológicas.

El área se distingue por un enfoque de vigilancia clínica participativa, fundamentado en los siguientes pilares:

1. **Centro de Diagnóstico Diferencial:** La unidad cuenta con el equipamiento y el personal entrenado para distinguir patologías ginecológicas críticas de eventos obstétricos comunes, garantizando que casos como el de la miomatosis uterina no sean subestimados.
2. **Gestión del Cuidado Humanizado:** Se promueve una atención que escucha activamente a la paciente y su entorno, entendiendo que el acompañamiento emocional es vital durante procesos que generan pérdida hemática y compromiso hemodinámico.
3. **Eje de Educación Comunitaria:** El servicio actúa como un aula abierta, donde el equipo de enfermería no solo administra tratamientos, sino que instruye a las mujeres sobre el

reconocimiento de signos de alarma, como el sangrado acíclico y la fatiga extrema por anemia.

4. **Compromiso con la Excelencia:** La unidad fomenta la actualización constante de sus enfermeros, buscando soluciones óptimas que eliminen el margen de error en el manejo de vías excretoras y control de signos de flogosis.

Desde esta perspectiva, la unidad de ginecología del hospital no solo se proyecta como un lugar solo para postparto y la cura de infecciones, sino como un entorno seguro donde la capacidad técnica y el conocimiento se ponen al servicio de la comunidad para prevenir complicaciones mayores en la salud femenina.

Misión

Orientar las acciones del equipo de enfermería hacia una atención ginecológica integral y de alta calidad, centrada en la detección oportuna de patologías hemorrágicas que afecten la estabilidad de la mujer. Todo esto bajo el principio de que cada mujer tiene derecho a vivir en las mejores condiciones de salud y a recibir una educación sanitaria que le permita ser partícipe de su propio bienestar.

Fomentando una cultura de aprendizaje continuo y seguridad del paciente en el fortalecimiento de el juicio clínico del personal de enfermería mediante talleres de diagnóstico diferencial y la discusión de casos clínicos, garantizando así la capacidad de discernir con precisión entre un mioma abortivo y eventos obstétricos. Comprometiéndonos a transformar la atención hospitalaria en un espacio de formación para la mujer, implementando estrategias de consejería individual y material informativo sobre signos de alerta hemorrágica. Promoviendo la actualización permanente y una práctica profesional basada en la evidencia que empodere a la mujer en el cuidado de su salud reproductiva.

Visión

Como estudiantes de enfermería, proyectamos convertir este caso clínico en un referente de aprendizaje que impulse una identidad profesional renovada, donde la capacidad de observación y el ojo clínico sean nuestras mejores herramientas. Aspiramos a que nuestra intervención en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, sea un aporte para consolidar un modelo de atención donde el estudiante no solo ejecute tareas, sino que sea capaz de liderar la prevención y el tratamiento de patologías complejas como el mioma abortivo, evitando que se confundan con procesos comunes.

Nos visualizamos como futuros profesionales que humanizan la salud a través de la educación, logrando que cada paciente atendida salga del servicio con el conocimiento necesario para no ignorar las señales de su cuerpo. Siguiendo nuestra meta de gestionar procesos de cuidado con margen de error pero donde la formación académica recibida y la ética profesional se unan para ofrecer soluciones reales, seguras y asertivas a la comunidad femenina de nuestra ciudad.

Objetivo General:

Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería a una paciente femenina de 47 años con diagnóstico de mioma abortivo, hospitalizada en el servicios de Ginecología Obstetricia del Hospital “Dr Felipe Guevara Rojas”.

Objetivo Específico:

- Valorar a la paciente de forma integral mediante los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon y el examen físico por sistemas, haciendo énfasis en las características del sangrado, los signos de hipovolemia y la ausencia de tejido ovular.
- Diagnosticar las necesidades prioritarias utilizando la taxonomía NANDA, incluyendo diagnósticos reales y de riesgo
- Planificar intervenciones de enfermería (NIC) orientadas a la estabilidad hemodinámica y a la educación sanitaria.
- Ejecutar las acciones de enfermería planificadas, incluyendo la administración de fármacos específicos, la monitorización del sangrado y la implementación de un programa educativo breve sobre la diferencia entre mioma abortivo y aborto espontáneo.
- Evaluar la respuesta clínica de la paciente y el logro educativo.

MARCO TEÓRICO

1. Anatomía y Fisiología del útero

El útero es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica, entre la vejiga urinaria por delante y el recto por detrás. Tiene forma de pera invertida y mide aproximadamente 7-8 cm de largo, 5 cm de ancho y 2-3 cm de espesor en la mujer adulta no gestante. Su función principal es albergar, nutrir y proteger al embrión y al feto durante el embarazo, así como participar en la expulsión del producto de la concepción durante el parto.

El útero se divide anatómicamente en tres porciones: el fondo (porción superior y redondeada), el cuerpo (porción central y más voluminosa) y el cérvix o cuello uterino (porción inferior que protruye hacia la vagina).

Histológicamente, el útero está compuesto por tres capas. La más externa es el perimetrio, una membrana serosa que recubre el órgano. La capa media es el miometrio, formado por fibras musculares lisas dispuestas en tres capas (longitudinal, circular y oblicua), cuya propiedad más importante es la contractilidad, esencial para la expulsión del contenido uterino durante la menstruación, el parto o ante cuerpos extraños como un mioma en proceso de expulsión. La capa más interna es el endometrio, un epitelio glandular altamente vascularizado que se engrosa ciclicamente bajo el estímulo de los estrógenos y la progesterona, y que se desprende durante la menstruación en ausencia de implantación embrionaria.

El ciclo menstrual, de aproximadamente 28 días, se divide en fase folicular (días 1-14), ovulación (día 14) y fase lútea (días 15-28). Durante la fase folicular, los estrógenos estimulan la proliferación del endometrio; tras la ovulación, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo transforma el endometrio en un tejido secretor apto para la implantación. Si no hay embarazo, los niveles hormonales descienden, el endometrio se necrosa y se desprende, generando el sangrado menstrual, que normalmente dura entre 3 y 7 días, con una pérdida media de 30 a 80 ml de sangre.

2. **Miomas Uterinos (Leiomiomas)**

Los miomas uterinos, también llamados leiomiomas o fibromas, son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital femenino. Se originan a partir de la proliferación monoclonal de células del músculo liso del miometrio. Su prevalencia aumenta con la edad, afectando hasta al 70-80% de las mujeres al llegar a los 50 años, aunque muchas son asintomáticas. Son hormonodependientes, es decir, su crecimiento está estimulado por los estrógenos y la progesterona; por ello, crecen durante la edad fértil, tienden a aumentar de tamaño durante el embarazo y suelen involucionar tras la menopausia.

Los miomas se clasifican según su localización con respecto a las capas uterinas. Los miomas subserosos se desarrollan hacia la capa externa del útero, pueden ser pediculados con un tallo y generalmente causan síntomas compresivos sobre órganos vecinos, pero no suelen producir sangrado abundante. Los miomas intramurales crecen dentro del espesor del miometrio, son los más frecuentes y pueden causar menorragia sangrado menstrual abundante y dismenorrea.

Los miomas submucosos se desarrollan justo debajo del endometrio, protruyendo hacia la cavidad uterina son los menos frecuentes pero los más sintomáticos, ya que distorsionan la cavidad endometrial, aumentan la superficie vascular y dificultan la correcta contractilidad uterina, lo que genera sangrados muy abundantes, a menudo con coágulos, y se asocian a infertilidad y abortos recurrentes.

Clínicamente, los miomas pueden ser asintomáticos o manifestarse con menorragia, sangrado menstrual excesivo en duración o cantidad, metrorragia sangrado entre periodos, dismenorrea dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico, síntomas compresivos como polaquiuria (micción frecuente) si comprimen la vejiga o estreñimiento si comprimen el recto, y en algunos casos, infertilidad o complicaciones obstétricas.

El diagnóstico de los miomas se realiza mediante ecografía pélvica (transabdominal o transvaginal), que permite visualizar su tamaño, número y localización. En casos complejos, se puede utilizar resonancia magnética. El tratamiento depende de los síntomas, la edad y los deseos reproductivos de la mujer, e incluye desde manejo expectante en asintomáticas, tratamiento farmacológico, hasta tratamientos quirúrgicos como la miomectomía o la histerectomía

3. Fisiopatología del mioma abortivo (Mioma en expulsión)

El mioma abortivo, también denominado mioma en expulsión, mioma parido o aborto miomatoso, es una complicación infrecuente pero potencialmente grave de los miomas submucosos pediculados. El término "abortivo" no se refiere a un aborto gestacional, sino a la similitud clínica con un aborto: el útero sufre contracciones intensas que intentan expulsar el mioma a través del cérvix, de manera análoga a la expulsión de un producto de la concepción. Esta confusión terminológica es precisamente la causa principal de los errores diagnósticos, ya que tanto profesionales como pacientes asocian erróneamente la palabra "aborto" a una pérdida gestacional.

El mecanismo fisiopatológico comienza con la presencia de un mioma submucoso, generalmente de tipo pediculado, es decir, unido al miometrio por un tallo delgado. Bajo ciertas circunstancias, como cambios hormonales, isquemia, degeneración del mioma (especialmente degeneración roja, que ocurre por trombosis de los vasos que irrigan el tumor) o simplemente por el crecimiento del mioma, el útero inicia contracciones rítmicas e involuntarias.

Estas contracciones, similares a las del trabajo de parto, ejercen presión sobre el mioma y lo empujan hacia el cérvix. El tallo se elonga y torsiona, comprometiendo aún más el riego sanguíneo, lo que agrava la necrosis y el dolor. A medida que el mioma desciende por el canal cervical, desgarrar vasos endometriales y cervicales, generando un sangrado agudo, profuso, de color rojo brillante y con abundantes coágulos, debido a que la sangre se acumula en la cavidad uterina y se coagula antes de ser expulsada.

El sangrado en el mioma abortivo tiene características distintivas. Es acíclico (no sigue el patrón menstrual), de inicio súbito, con una cantidad que puede superar fácilmente los 500 ml en pocas horas, lo que pone a la mujer en riesgo de shock hipovolémico. A diferencia de una menstruación abundante, la paciente refiere sentir "expulsión de algo" y, en ocasiones, puede visualizar tejido de aspecto carnoso (el propio mioma necrosado) en las compresas o en el inodoro, lo que refuerza la confusión con un aborto espontáneo. Sin embargo, el examen anatomopatológico de ese tejido no muestra vellosidades coriales ni tejido embrionario, sino fibras musculares lisas con degeneración hialina o roja.

El diagnóstico diferencial entre mioma abortivo y aborto espontáneo es crucial y se basa en los siguientes criterios. En el aborto espontáneo, la paciente refiere retraso menstrual o amenorrea previa, la prueba de embarazo (en sangre u orina) es positiva, la ecografía transvaginal muestra un saco gestacional, embrión o restos ovulares dentro del útero o en el canal cervical, y el dolor suele ser tipo cólico intenso y rítmico. En el mioma abortivo, no hay retraso menstrual (de hecho, puede haber amenorrea o ciclos irregulares por la edad perimenopáusica de la paciente), la prueba de embarazo es negativa, la ecografía muestra un útero aumentado de tamaño con un mioma submucoso pediculado que protruye hacia el canal cervical, y no se visualiza saco gestacional. El dolor puede estar presente o no, y suele ser menos intenso que en el aborto.

Las complicaciones del mioma abortivo incluyen la hemorragia severa con shock hipovolémico, que puede ser mortal si no se trata a tiempo; la infección secundaria (endometritis o absceso pélvico) si el mioma necrosado permanece retenido; la perforación uterina durante el intento de extracción; y la anemia aguda post-hemorrágica que requiere transfusión sanguínea.

El tratamiento del mioma abortivo tiene dos fases:

La fase aguda se centra en la estabilización hemodinámica de la paciente: canalización de vías venosas de grueso calibre, administración de cristaloides, transfusión si es necesaria, y fármacos hemostáticos como ácido tranexámico (antifibrinolítico) y vitamina K (para optimizar la coagulación). Una vez estable, se procede a la extracción del mioma, que puede ser mediante torsión y corte del tallo bajo visión especular (si el mioma ya ha descendido a la vagina) o mediante histeroscopia quirúrgica (si el mioma está aún dentro de la cavidad uterina). En casos de sangrado incontrolable o miomas múltiples, puede ser necesaria una miomectomía abdominal o, en mujeres sin deseos reproductivos, una histerectomía.

4. La confusión diagnóstica entre Mioma Abortivo y Aborto Espontáneo

El término "mioma abortivo" es, en sí mismo, desafortunado porque induce a error. La palabra "aborto" en el lenguaje común y clínico se refiere a la interrupción del embarazo, ya sea espontánea o inducida. Por ello, cuando una enfermera o un médico escucha "mioma abortivo", puede pensar erróneamente que se trata de un aborto espontáneo en una paciente portadora de miomas, o que es un tipo de aborto.

Esta confusión no es semántica; tiene consecuencias prácticas graves. Una paciente etiquetada como "aborto espontáneo" puede ser manejada con legrado uterino, que en el contexto de un mioma abortivo puede ser inútil (porque no hay restos ovulares) o peligroso (porque puede perforar el útero o desencadenar una hemorragia mayor). Además, la paciente sufre un daño psicológico innecesario al creer que ha perdido un embarazo.

Por otro lado, la propia mujer confunde su sangrado con una menstruación abundante o con un aborto. En el caso clínico presentado, la paciente de 47 años, con amenorrea de 5 meses (probablemente por transición a la perimenopausia), interpretó inicialmente el sangrado como una "menstruación que volvía". Al persistir y ser abundante, pensó que podría ser un aborto, pero nunca consideró la posibilidad de un mioma complicado porque nadie le había explicado que los miomas pueden degenerar y expulsarse.

Esta doble confusión (en el profesional y en la paciente) convierte al mioma abortivo en un problema de educación sanitaria. El profesional de enfermería debe ser capaz de hacer el diagnóstico diferencial correcto, utilizando criterios clínicos claros (prueba de embarazo negativa, ecografía sin saco gestacional, visualización del mioma en el canal cervical). Y la mujer debe ser educada para que entienda que un sangrado con coágulos grandes, fuera del período menstrual, con prueba de embarazo negativa, puede ser un mioma abortivo, y que requiere atención médica urgente para evitar una hemorragia grave.

5. Papel de la enfermería en el manejo del Mioma Abortivo

La enfermería tiene un rol protagónico en tres niveles: asistencial, educativo y de gestión del cuidado. En el nivel asistencial, la enfermera es la responsable de la monitorización hemodinámica continua, la administración segura de fármacos (vitamina K, ácido tranexámico), la cuantificación precisa de la pérdida sanguínea, y la preparación para procedimientos quirúrgicos (extracción del mioma). También debe reconocer precozmente los signos de shock hipovolémico y activar los protocolos de código hemorragia si es necesario.

En el nivel educativo, la enfermera debe educar a la paciente y su familia sobre la naturaleza del mioma abortivo, desterrando el mito de que fue un aborto espontáneo, y enseñando los signos de alarma para que no normalice un sangrado anormal en el futuro.

Además, este caso clínico demuestra que la educación debe extenderse al propio personal de enfermería, ya que el desconocimiento del mioma abortivo es frecuente. La enfermera puede liderar sesiones educativas breves en los pases de visita, utilizando tablas comparativas y casos clínicos reales para fijar el aprendizaje.

En el nivel de gestión del cuidado, la enfermera coordina las interconsultas con Ginecología, garantiza que el diagnóstico correcto quede registrado en la historia clínica (evitando el término "aborto espontáneo"), y planifica el seguimiento post-alta, incluyendo la cita para tratamiento definitivo del mioma residual.

Historia Clínica

Paciente: J.P. **Edad:** 47 años. **Servicio:** Ginecología/Obstetricia. **Fecha de ingreso:** 13-04-2026

Motivo de Ingreso: Sangrado a través de genitales externos.

Resumen del ingreso:

Se trata de paciente de 47 años de edad, natural de Valencia precedente de la localidad quien acude al servicio de urgencias del Hospital “Dr Felipe Guevara Rojas “ por presentar sintomatología hace 8 días, aproximadamente 07-04-2026 cuando comenzó a presentar sangrado a través de genitales externos en abundante cantidad con coágulos de forma acíclica, no fetido. Motivo por el cual acude a consulta donde se evalúa y se decide su ingreso. Al ingresar la paciente tiene autonomía.

Antecedentes Personales: Hipertensión arterial (HTA). Refiere en 2011 cesárea por paridad satisfactoria. Cirugía de "globular" (probable globo vesical) el año pasado. Niega alergias a medicamentos

Antecedentes Familiares: Madre Fallecida ; Padre Fallecido ; Hermanos: 3 ; Hijos: 3

Antecedentes Ginecoobstétricos: Menarquia a los 10 años; Ciclo:5/21; Tipo: Dismenorrea; Sexarquia: 17 años; NPS: 2 ; Citología: 14años ; Gestas: 4 : Partos: 3 : Cesáreas: 1; Abortos: 1.

Antecedentes Psicobiológicos: Café 2 tazas al día. Niega tabaquismo, alcohol y drogas.

Diagnóstico de ingreso: Sangrado uterino anómalo. Mioma abortivo (uterina submucosa grado 0 o I) confirmado por ecografía y tacto bimanual.

Examen Físico

- **Signos Vitales:** TA: 120/100 mmHg, FC: 71 lpm, FR: 18rpm, Temp: 36.8°C, SpO2:97%
- **Aspectos generales:** Regular estado general, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Pálida, mucosas orales húmedas pero palidas. Llenado capilar < 3 segundos.
- **Sistema cardiovascular:** Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. Pulsos periféricos presentes.
- **Sistema respiratorio:** Pulmones ventilados, sin ruidos agregados.
- **Sistema gastrointestinal:** Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos presentes.
- **Sistema genitourinario:** Genitales externos de aspecto normal. Al examen presenta: sangrado activo a través del orificio cervical externo, con coágulos, sin tejido ovular visible. Se realiza acto bimanua encontrándose utero aumentado de tamaño, a su vez dividido por encima de la sínfisis del pubis, en AVF, de bordes regulares. Cuello no se tacta por mioma abortivo. Se evidencia sangrado moderado con coágulos, no fetido.
- **Sistema tegumentario:** Piel pálida, turgencia conservada. No edemas.
- **Sistema neurológico:** Paciente consciente en tiempo, espacio y persona. Responde coherentemente a las preguntas realizadas.

Patrones Funcionales de Marjory Gordon

Para la paciente, basándonos en el modelo de los 11 Patrones Funcionales de Marjory Gordon, el análisis de los patrones alterados se organiza desde el que compromete la estabilidad hemodinámica de forma inmediata hasta aquellos que afectan su conocimiento y manejo de la salud.

1. Patrón de Percepción - Manejo de la Salud

La paciente manifiesta una gestión ineficaz de su propia salud, admitiendo que consideró el sangrado como "una menstruación fuerte" y no acudió de inmediato al médico, lo que retrasó la atención durante 6 días. El familiar refiere que la paciente desconoce que un sangrado con coágulos grandes puede ser una emergencia y que nunca le habían explicado qué es un mioma abortivo.

2. Patrón Nutricional - Metabólico

Sin alteraciones previas significativas, pero la pérdida sanguínea prolongada la pone en riesgo de anemia ferropénica. Refiere apetito conservado y sed normal. Al examen físico, mucosas orales pálidas pero húmedas.

3. Patrón Eliminación

Eliminación urinaria y fecal normal, sin alteraciones. La alteración principal se encuentra en la eliminación vaginal: sangrado transvaginal abundante con coágulos, acíclico, no fétido, que ha requerido cambio de compresa cada 30-60 minutos en las primeras horas de evolución.

4. Patrón Actividad - Ejercicio

Refiere fatiga y debilidad por la pérdida de sangre, pero logra deambular con ayuda dentro de la habitación. La observación clínica muestra una paciente con movilidad conservada pero con limitación por astenia.

5. Patrón Sueño - Descanso

Refiere sueño interrumpido durante los días previos al ingreso por la necesidad de levantarse a cambiar compresas y por la ansiedad ante el sangrado. Durante la hospitalización, con el control del sangrado, logra períodos de descanso más prolongados.

6. Patrón Cognitivo - Perceptual

La paciente se encuentra consciente y orientada en sus tres planos. Comprende las indicaciones del personal de salud, pero expresa confusión sobre su diagnóstico: "¿Estoy perdiendo un bebé? ¿Esto es un aborto?" Evidencia un déficit de conocimiento sobre su diagnóstico real (mioma abortivo). No presenta dolor intenso, solo molestia pélvica leve. La velocidad de respuesta es adecuada.

7. Patrón Autopercepción - Autoconcepto

Refiere miedo y angustia por el sangrado abundante. Al explicarle que no es un aborto espontáneo, muestra alivio pero también frustración por no haber conocido antes esta posibilidad. Su autoestima se mantiene conservada, aunque expresa preocupación por su salud futura.

8. Patrón Rol - Relaciones

La paciente vive con su pareja, quien la acompaña durante la hospitalización. Ambos refieren temor e incertidumbre iniciales, pero se muestran colaboradores con el tratamiento. La red de apoyo está presente y funcional.

9. Patrón Sexualidad - Reproducción

Menarquia a los 10 años. FUR: hace 5 meses (amenorrea secundaria, probable transición a la perimenopausia). Gestas: 4 , partos: 3, abortos: 1. Refiere vida sexual activa con su pareja. No utiliza métodos anticonceptivos.

10. Patrón Tolerancia al Estrés - Afrontamiento

Se identifica un afrontamiento inicial ineficaz por desconocimiento de la enfermedad, ya que la paciente refiere sentirse abrumada por la cantidad de sangrado y el miedo a un diagnóstico grave. Sin embargo, al recibir información clara, apoyo emocional y educación sobre el mioma abortivo, la paciente muestra disposición a colaborar y aprender, utilizando mecanismos de afrontamiento más adaptativos.

11. Patrón Valores - Creencias

La paciente, de 47 años, profesa la religión evangélica, cuyos principios doctrinales influyen directamente en sus decisiones sobre procedimientos médicos. Si bien valora su salud y reconoce la necesidad de tratar su condición ginecológica, sus creencias religiosas le impiden aceptar la cirugía como opción terapéutica, pues considera que ciertas intervenciones quirúrgicas (especialmente aquellas que pudieran afectar su integridad reproductiva o implicar transfusiones sanguíneas) contravienen los preceptos de su fe.

Agradece la explicación honesta sobre su diagnóstico, pero solicita explorar alternativas no quirúrgicas que respeten sus convicciones. A sus 47 años, no planea más embarazos, aunque su negativa a la cirugía no deriva de un deseo de fertilidad futura, sino de un mandato religioso que prioriza el cuerpo como templo del Espíritu Santo y rechaza ciertas prácticas invasivas.

Teoría del Déficit del Autocuidado de Dorothea Orem

La Teoría de Enfermería de Dorothea Orem se fundamenta en la premisa de que todos los seres humanos tienen la capacidad y el deber de cuidar de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. Esta estructura teórica se divide en tres partes esenciales: la Teoría del Autocuidado, la Teoría del Déficit de Autocuidado y la Teoría de los Sistemas de Enfermería. El Autocuidado se define como el conjunto de acciones intencionadas que una persona realiza para regular su propio funcionamiento; estas acciones responden a requisitos universales (como respirar y alimentarse), de desarrollo (etapas de la vida) y de desviación de la salud (cuando surge una enfermedad).

El concepto central, el Déficit de Autocuidado, surge cuando la "Demanda de Autocuidado Terapéutico" es decir, el total de acciones necesarias para recuperar la salud supera la "Agencia de Autocuidado", que es la capacidad, fuerza y conocimiento del individuo para realizar dichas acciones. En este punto, la enfermería se vuelve necesaria no para reemplazar al individuo, sino para actuar como un agente externo que ayuda a cubrir esa deficiencia. La intervención profesional se organiza a través de tres Sistemas de Enfermería: el Totalmente Compensatorio (la enfermera hace todo), el Parcialmente Compensatorio (ambos colaboran) y el de Apoyo-Educativo (el paciente aprende a realizar su propio cuidado).

Relación de la Teoría con el caso

En este caso clínico, la relación con la teoría de Orem es directa debido a la naturaleza aguda y educativa del mioma abortivo. La paciente presenta una desviación de la salud severa que ha alterado sus requisitos universales, específicamente el mantenimiento de un volumen circulatorio adecuado debido a la hemorragia activa. Al ingresar con sangrado profuso y signos de hipovolemia, su Agencia de Autocuidado física está parcialmente comprometida posee la energía para comunicarse y colaborar, pero requiere intervención de enfermería para detener hemorragia y estabilizarla.

El Déficit de Autocuidado en esta paciente es principalmente de tipo cognitivo y educativo. La paciente desconoce la existencia del mioma abortivo, confunde su sangrado con un aborto espontáneo o con una menstruación abundante, y no identifica los signos de alarma de una hemorragia grave. Su agencia de autocuidado está comprometida por la falta de información, no por incapacidad física. La teoría de Orem nos permite identificar que la demora en acudir a urgencias no fue un simple "descuido", sino un déficit real en su capacidad de procesar la gravedad de su cuadro, exacerbado por la falta de educación sanitaria previa.

El déficit de autocuidado también se extiende al personal de enfermería en el contexto de este caso como estrategia educativa. Muchos enfermeros desconocen el mioma abortivo y podrían etiquetar erróneamente a la paciente como "aborto espontáneo" en los registros, lo que retrasaría el manejo adecuado. Por lo tanto, la demanda de autocuidado terapéutico para el equipo de salud incluye la necesidad de formación continua.

Por último, el plan de cuidados se establece bajo un Sistema de Apoyo-Educativo para la paciente (ya que conserva sus capacidades funcionales) y un Sistema de Apoyo-Educativo para el personal de enfermería (mediante una sesión educativa durante el pase de visita). La enfermera interviene educando sobre la fisiopatología del mioma abortivo, enseñando a diferenciarlo del aborto espontáneo, y supervisando la administración de fármacos hemostáticos.

El objetivo terapéutico, bajo la visión de Orem, es transformar a la paciente de una persona con conocimientos deficientes a una Agente de Autocuidado competente, capaz de reconocer signos de alarma y buscar ayuda oportuna, y al personal de enfermería en profesionales capaces de diagnosticar correctamente esta entidad.

Plan de Atención Real

Dominio 1: Promoción de la salud. Clase 2: Gestión de la salud. Diagnóstico NANDA (00369). Autogestión ineficaz de la salud
r/c déficit de conocimiento sobre la diferencia entre mioma abortivo y aborto espontáneo, y desconocimiento de los signos de alarma de hemorragia grave, m/p verbalización de confusión, demora en acudir a urgencias y falta de reconocimiento de la gravedad del cuadro.

Teoría de Dorothea Orem	Objetivos (NOC)	Intervenciones (NIC)	Razonamiento Científico	Evaluación
Sistema de Apoyo-Educativo: La enfermera actúa como guía facilitador a para que la paciente recupere su agencia de autocuidado, proporcionando los conocimientos y el soporte emocional necesarios para que ella misma gestione su salud de forma autónoma	(1823) Conocimiento: Fomento de la salud. (1820) Conocimiento: Control de la enfermedad. Indicador: La paciente identificará la diferencia entre mioma abortivo y aborto espontáneo y verbalizar al menos 3 signos de alarma de hemorragia grave antes del alta médica.	(5602) Enseñanza: Proceso de la enfermedad: Explicar con lenguaje sencillo qué es un mioma abortivo usando una clara comparación con aborto espontáneo. (5270) Apoyo Emocional: Escucha activa y fomento de la expresión de sentimientos sobre su diagnóstico.	El aprendizaje terapéutico motiva al paciente al reducir el déficit de conocimiento. Diferenciar el mioma abortivo del aborto espontáneo elimina la confusión diagnóstica, reduciendo el sufrimiento psicológico, innecesario y empodera a la paciente para actuar ante una recurrencia, reduciendo el riesgo de futuras hemorragias graves.	La paciente manifiesta verbalmente comprender la diferencia entre mioma abortivo y aborto espontáneo, expresa alivio al saber que “no fue un aborto”, y enumera correctamente al menos tres signos de alarma (sangrado que empapa una compresa en menos de 1 hora, mareos, palidez intensa). Se compromete a acudir a control ginecológico para tratamiento definitivo.

Ficha Farmacológica

Nombre del Medicamento	Mecanismo de Acción	Farmacodinamia	Farmacocinética	Indicaciones en este caso
Solución Fisiológica 0.9% (HP 1500cc)	Solución isotónica de electrolitos que expande el volumen del líquido extracelular	Repone agua y electrolitos (cloruro de sodio) para mantener el equilibrio osmótico y la volemia	Distribución: Rápida al espacio extracelular. Excreción: Principalmente renal.	Mantener la hidratación y la estabilidad hemodinámica de la paciente, especialmente si hay pérdida de sangre o vómitos
Ranitidina (Amp VEV)	Antagonista competitivo de los receptores H ₂ de histamina en las células parietales gástricas.	Inhibe la secreción de ácido gástrico basal y estimulada, reduciendo el volumen y la acidez del jugo gástrico.	Metabolismo: Hepático (parcial). Excreción: Renal (mayoría inalterada). Vida media: 2-3 horas.	Prevención de la gastritis medicamentosa o úlceras por estrés durante la hospitalización y el tratamiento con otros fármacos.
Ciclokapron (Ácido Tranexámico) (Amp EV)	Antifibrinolítico sintético que inhibe competitivamente la activación del plasminógeno en plasmina.	Bloquea la unión del plasminógeno a la fibrina, estabilizando el coágulo y reduciendo significativamente la disolución de los mismos (fibrinólisis).	Distribución: Se distribuye en todos los tejidos. Metabolismo: Mínimo. Excreción: Renal (90% inalterado). Vida media: 2-3 horas.	Control de la metrorragia (sangrado uterino abundante) severa asociada a la presencia y posterior expulsión del mioma abortivo
Ácido Fólico + Complejo B (Amp o Sol VEV)	Vitaminas hidrosolubles esenciales para procesos metabólicos.	A. Fólico: Coenzima en síntesis de ADN. Comp. B: Coenzimas en metabolismo energético y función nerviosa.	Distribución: Amplia. Metabolismo: Hepático. Excreción: Renal.	Apoyo nutricional y prevención de anemia si hay sangrado uterino anormal significativo.

Conclusión

El presente caso clínico tuvo como propósito principal no solo la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en una paciente con mioma abortivo, sino también, y de manera fundamental, educar al personal de enfermería y a las mujeres sobre una entidad que suele ser confundida con un aborto espontáneo. A lo largo del análisis, se evidenció que el término "mioma abortivo" genera por sí mismo una confusión semántica y clínica, llevando a muchos profesionales a etiquetar erróneamente estos casos como "aborto en curso", cuando en realidad no existe gestación alguna.

Desde una perspectiva pedagógica, este caso demuestra que el conocimiento del mioma abortivo no está suficientemente difundido en los programas de formación de enfermería ni en la educación sanitaria dirigida a la población femenina. La paciente de 47 años tardó seis días en acudir al hospital porque creía que su sangrado era "una menstruación irregular" o "un aborto espontáneo", términos que ella conocía, pero nunca había escuchado sobre la posibilidad de que un mioma uterino pudiera necrosarse, degenerar y ser expulsado por el útero, causando una hemorragia potencialmente mortal.

Por lo tanto, la principal conclusión de este caso es de carácter educativo: los profesionales de enfermería deben ser capaces de diferenciar clínicamente el mioma abortivo del aborto espontáneo mediante tres preguntas clave: ¿la prueba de embarazo es positiva o negativa? ¿La ecografía muestra saco gestacional o un mioma en el canal cervical? ¿El tejido expulsado contiene vellosidades coriales o es tejido miomatoso? Estas tres preguntas, integradas en la práctica diaria, pueden salvar vidas al evitar demoras en el manejo hemodinámico y al prevenir intervenciones innecesarias como el legrado uterino.

Se concluye que las mujeres deben ser educadas para que no normalicen un sangrado abundante con coágulos grandes, especialmente aquellas entre los 40 y 50 años con antecedente de miomas uterinos. Una mujer informada es capaz de reconocer los signos de alarma (empapar más de una compresa por hora, mareos, palidez, expulsión de coágulos grandes) y acudir a urgencias sin demora, rompiendo el mito de que "es solo una regla fuerte" o "estoy perdiendo un bebé".

La aplicación de la teoría de Dorothea Orem bajo el sistema de apoyo-educativo resultó ser el marco teórico más adecuado para este caso, pues permitió identificar que el déficit de autocuidado en la paciente no era físico, sino cognitivo-informacional. Al educarla, se restauró su agencia de autocuidado y se le entregó una herramienta de prevención para el futuro. En síntesis, este caso clínico no es solo una lección académica: es una herramienta pedagógica y para cambiar la práctica clínica y empoderar a las mujeres.

A pesar del manejo inicial, la paciente mantiene una hemoglobina de 7,9 g/dL, reflejo de la hemorragia severa sostenida. Ante el riesgo vital inminente, la paciente ha aceptado finalmente realizarse la cirugía (histerectomía o miomectomía según corresponda). En este momento, el equipo médico se encuentra a la espera de que los niveles de hemoglobina se estabilicen y mejoren con el soporte transfusional y farmacológico, para poder programar la intervención quirúrgica en condiciones de seguridad óptimas.

Recomendaciones Finales

1. **Considerar la administración de Vitamina K en sangrados uterinos severos asociados a mioma abortivo:** Si bien no fue administrada en este caso por no contar con criterios de déficit evidente, se recomienda valorar la inclusión de Vitamina K (fitomenadiona) en el protocolo de manejo de hemorragia por mioma abortivo, especialmente cuando hay sospecha de coagulopatía por consumo, hepatopatía, desnutrición o uso prolongado de antibióticos que alteren la flora productora de vitamina K. Su administración (vía intramuscular o intravenosa lenta) puede favorecer la síntesis hepática de factores de coagulación y contribuir al control hemorrágico, previa evaluación de riesgos y beneficios.
2. **Incluir el mioma abortivo en los contenidos curriculares de enfermería:** Se recomienda a las escuelas y facultades de enfermería incorporar el estudio del mioma abortivo como un tema específico dentro de las asignaturas de Ginecología y Urgencias. El abordaje debe incluir su fisiopatología, diagnóstico diferencial con el aborto espontáneo y el manejo inicial de enfermería, utilizando casos clínicos simulados para fijar el aprendizaje.
3. **Realizar sesiones educativas periódicas en los servicios de Ginecología y Urgencias:** El personal de enfermería debe recibir capacitación anual sobre el sangrado uterino anómalo, con énfasis en el mioma abortivo. Se sugiere una sesión de 20 minutos durante el pase de visita, utilizando una tabla comparativa visual que destaque las diferencias clave: prueba de embarazo negativa, ecografía sin saco gestacional, ausencia de vellosidades coriales en el tejido expulsado.
4. **Diseñar material educativo para mujeres en las salas de espera de Ginecología y consulta externa:** Elaborar un cartel o tríptico titulado "¿Sabías que un mioma puede sangrar como un aborto pero no es un embarazo?", dirigido a mujeres de 40 a 50 años. El material debe explicar, en un lenguaje sencillo pero preciso, qué es un mioma abortivo, cuáles son los signos de alarma (sangrado con coágulos grandes, compresa empapada en menos de una hora, mareos) y la importancia de acudir a urgencias sin demora.

5. **Capacitar a las mujeres en la auto-medición del sangrado menstrual:** En las consultas de enfermería ginecológica, se debe enseñar a las mujeres a cuantificar su pérdida sanguínea usando el método de "compresas por hora". Una compresa de alta absorción completamente empapada en menos de una hora durante dos horas consecutivas constituye una emergencia. Este conocimiento es especialmente relevante en mujeres con miomas conocidos.

Reflexiones Como Futuros Profesionales de la Enfermería

Al concluir este caso clínico, nos llevamos algo más que una calificación o un trabajo académico aprobado. Nos llevamos una lección de humanidad y de responsabilidad profesional que ninguna clase teórica nos había enseñado con tanta claridad.

Cuando empezamos a analizar la historia de esta paciente de 47 años, lo primero que nos llamó la atención fue el tiempo que tardó en buscar ayuda: seis días con un sangrado abundante, con coágulos grandes, pensando que era "normal" o que "tal vez era un aborto". Y luego, al revisar la literatura, descubrimos algo que nos preocupó profundamente: muchos profesionales de enfermería tampoco saben qué es un mioma abortivo. Algunos nunca habían escuchado el término. Otros lo confundían directamente con un aborto espontáneo. Eso significa que no solo las mujeres están desinformadas; también nosotros, los que estamos llamados a cuidarlas.

Nos hizo reflexionar sobre el verdadero significado de ser enfermero o enfermera. No basta con saber tomar signos vitales, canalizar una vía o administrar un medicamento. Si no sabemos interpretar lo que vemos, si no somos capaces de preguntarnos ¿esto que parece un aborto, lo es realmente?, entonces estamos fallando en lo más esencial de nuestra profesión: la capacidad de pensar críticamente y de proteger a la persona que confía en nosotros.

La confusión entre mioma abortivo y aborto espontáneo no es un error menor. Tiene consecuencias reales: una mujer que cree que perdió un bebé cuando nunca estuvo embarazada sufre un daño psicológico evitable. Un legrado innecesario expone a la paciente a riesgos de perforación uterina, infección o hemorragia. Un diagnóstico tardío puede convertir un sangrado controlable en un shock hipovolémico con desenlace fatal. Y todo esto puede prevenirse con una sola cosa: conocimiento.

Por eso, como futuros enfermeros, nos comprometemos a tres cosas. Primero, a nunca etiquetar un sangrado como "aborto espontáneo" sin antes verificar la prueba de embarazo y los hallazgos ecográficos. Segundo, a educar a cada mujer que pase por nuestras manos, explicándole que un sangrado con coágulos grandes no es normal, que no debe esperar, que su vida vale más que cualquier vergüenza o miedo. Y tercero, a compartir lo que aprendimos hoy con nuestros compañeros, con los que ya están trabajando y con los que vendrán después, porque

el conocimiento que no se comparte se pierde, y una vida perdida por ignorancia es una vida que no podemos recuperar.

Este caso clínico nos enseñó que la enfermería no es solo técnica, es también pedagogía. No solo curar, sino prevenir. No solo actuar, sino pensar. Y sobre todo, nos enseñó que lo que no se sabe, no se puede cuidar. Por eso, hoy sabemos algo nuevo: existe el mioma abortivo, no es un aborto, y debemos estar preparados para identificarlo y manejarlo. Ese es nuestro compromiso como futuros profesionales.

Referencias

Ministerio del Poder Popular para la Salud (2019). *Protocolos de atención en emergencias ginecológicas*. <http://www.mpps.gob.ve>

Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia. (2022). *Guías clínicas para el diagnóstico y tratamiento de miomas uterinos*. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 82(3), 245-260. <http://www.ve.scielo.org>

Mendez Rodríguez A., Moya Toneut, C., Moré Vega, A., Díaz Carmenate, Y., Rodríguez López, V. M., & Rodríguez Alemán O. A (2018). *Miomatosis uterina complicada con aborto de un mioma submucoso*. <http://scielo.sld.cu>

MedlinePlus. (2024). *Miomas uterinos*. *Enciclopedia médica*. Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. [https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000914.htm\[reference:1\]](https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000914.htm[reference:1])

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Prevención y manejo de la hemorragia obstétrica y ginecológica*. <https://iris.who.int/a>

Anexos



Figura 1. *Especuloscopia. Mioma que sobresale del cérvix dilatado y ocupa la vagina.*



Figura 2. *Imagen que muestra el tamaño del útero de aspecto fibromatoso y con mioma.*